جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نادية رشاد عبدالسلام ابوالسعود
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** ---
رقم البطاقة : 27712282101582 **رقم التليفون :** 01124869393 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 28-12-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمده 6 شهور [14163] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نادية رشاد عبدالسلام ابوالسعود
National ID: 27712282101582

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Goserelin (Zoladex) subcutaneous**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

السيد أ.د / مدير عام المجالس الطبيه

تحيه طيبه وبعد

كشف حساب

بيان بنفقات المريض / نادية رشاد

علاج على نفقة الدولة

عن الفتره من ٤/ ١١/ 2026 الى ٢٤/ ٥/ 2026

البيان	رصيد القرار	قيمة المنصرف
الرصيد	٣٣٤٥	
اقامة	0	0
كشف	0	0
اشراف طبي	0	0
اشعه (رنين - مقطعية - اخرى)	0	0
تحاليل طبيه	0	0
مستلزمات	0	0
علاج متنوعه (دم / علاج بنك)	0	0
الادويه	0	0
الإجمالي		١٥٦١

GRI-E جوستاف روسي - مصر

الموظف المختص

المراجع

٤٢٨١

كود المستشفى: 101813

وزارة الصحة و السكان
مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهره
جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE)

فاتورة علاج رقم ١٨٨٤٣١٨٢

تقر مستشفى جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) بأن أصول مستندات الصرف ومؤيداتها القانونية صحيحة وعلى مسئوليتنا.
وتم حفظها بغرفة الحفظ لدينا وتحت تصرف الجهاز المركزي للمحاسبات واننا لم ولن نتقدم بتلك الفاتورة لأي جهة اخرى للصرف.

اسم المريض	نادية رشاد عبدالسلام ابوالسعود	الرقم القومي	٢٧٧١٢٢٨٢١٠١٥٨٢
قرار وزاري رقم	٢٠٢٥٣٧٢٣٧٥٠٧ بتاريخ	٢٠٢٥-١١-٠١	بمبلغ ١١٣٢٥ مدة القرار ١٨٠ يوم
تاريخ الفاتورة	٢٠٢٥-١١-٠٨	التشخيص	سرطان بالثدي (مبكرة)
الإجراء	زولادكس تحت الجلد لمده 6 شهور (شامل المتابعه والتحاليل)	الخصم (%)	٠

مدين	بيان	كمية	وحدة	تاريخ الصرف	ملاحظات
٥٦٦٢.٨٦	Goserolin Acetate 10.8 mg	1	اخرى	08/11/2025	
٥٦٦٢.٨٦	الاجمالي				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الموظف المختص | المراجع | رئيس حسابات المرضى

ياسين طاهر | محمد فؤاد

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

Name: نادیه رشاد عبدالسلام ابوالسعود **MR. :** 6650	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with left breast cancer and underwent left breast conserving surgery on 12/6/2023. Pathology revealed pT2, pN0/5, ER 8/8, PR 8/8, HER2-negative. Post-operative adjuvant therapy was initiated with Bzoladex and Arimidex from 10/2023 through 02/2026, with Zometa added as needed. The patient has remained free of disease recurrence during this period.

The most recent assessment, conducted in February, indicates that the patient has continued on Arimidex with supportive therapy for the past three months. No additional chemotherapy or targeted agents have been added, and the patient remains under observation with routine follow-up.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **dina makram**

يعتمد ,





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نادية رشدة عبدالسلام ابو لسعود
Sex: Female
3- Medical number: 83139459
Old Pid :
15/6/2023

2-ID number: 27712282101582
Patient Age : 46 Y

Family history
Phone: 01124860393
DMI
REASON OF MDT
marital status
NRS Score
GROUP
Date of MDT: Post operative
Co morbidity
Menopausal status

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CTCAP:FREE

ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	KI67 :
8/8	8/8	0		5%

BX: IDC, G11

T	N	M
P(4CM)	0	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY

12/6/2023--> UPFRONT LT WLE AND SLNB
IDC G11,,,FREE MARGINS,,FREE LN 0/5
PT2 PN0

MDT OUTCOME & PLAN

1- ADJUVANT TAXOTERE ENDOXAN X4
2- ADJUVANT TAMOXIFEN+ZOLADEX
3- PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY	27/12/2023	PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Minkstry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Nadia Rashad Abdel Salam Aboul Sa'oud	Date : 04/06/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1576/2023	Pat. ID: 33356

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UIQ spiculated irregular mass lesions, of high density.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated hypoechoic mass lesions, seen at 11 to 12 o'clock position 3.5 cm from the nipple, 0.7cm from the overlying skin, largest measuring 1.6 x 3.3 cm.
- The previously mentioned left breast 3 o'clock distortion shows no definite underlying spiculated mass lesions.
- Nonspecific bilateral axillary LN.
- No pathological enlarged left infra or supra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UIQ multifocal malignant looking mass lesions (BIRADS 6) for further CESM to exclude multicentricity.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

04/06/2023 7:48 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Rashad Abd Al Salam Abu Al Saoud	Date : 07/05/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 45 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 33357

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

A known case of left breast cancer.

I Chest:-

- Bilateral apical ground glas patches and reticulations.
- No sizable pulmonary nodules and masses.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Opinion:

- **No pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.**

Dr. Aya Daebes, MSc
Dr. Amr Farouk, M.D.

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نادية رشاد عبدالسلام ابوالسعود Sex: Female
3- Medical number: 83139459
Old Med : 1576/2023

2-ID number: 27712282101582 Patient Age : 46 Y

Family history		Phone	01124869393	BMI		REASON OF MDT	Post op eval
marital status		NRS Score		GROUP		Date of MDT	2023-10-22
Co morbidity		Menopausal status					

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup : CTCAP:FREE

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
IDC GII	8/8	8/8	0		5%

T	N	M
P(4CM)	0	0

Sonomammiography

PATIENT HISTORY

12/6/2023--> UPFRONT LT WLE AND SLNB
IDC GII,,,FREE MARGINS,,FREE LN 0/5
PT2 PN0

MDT OUTCOME & PLAN

1- ADJUVANT TAXOTERE ENDOXAN X4
2- ADJUVANT TAMOXIFEN+ZOLADEX
3- PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY د/ حسن عزت د/ رضوى صبره	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY 22/12/2023	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذة / نهيه رشاد عبدالسلام ابو السعود	Request No.	: 13004752
Patient No.	: 27712282101582	Request Date	: 03/04/2023
Path No.	: 1026/23	Verification Date	: 07/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 03/04/2023, 09:00 pm.

Gross Examination:
- Fragmented grayish white tissue cores up to 0.5 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, Her2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma with lobular differentiation.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: No
* Perineural invasion: No
* Angioinvasion: No
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma with lobular differentiation, Grade II.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذة / نادية رشاد عبدالسلام ابو السعود	Request No.	: 13004752
Patient No.	: 27712282101582	Request Date	: 03/04/2023
Path No.	: 1026/23	Verification Date	: 07/05/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تكلفة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

- Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Signature
Prof. Dr. Imam Gouda
Dr. Hebatullah Mostafa

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / ناديه رشاد عبدالسلام ابو السعود	Request No.	: 13002549
Patient No.	: 27712282101582	Request Date	: 12/06/2023
Path No.	: 1874/23	Verification Date	: 17/07/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 45 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Left breast mass

Nature of the specimen:
Left wide local excision and sentenil lymph node biopsy specimens , collected at 12/6/23

Gross Examination:
Two specimens were recieved :
-Sentenil lymph node biopsy specimen : Three fibrofatty tissue peices measured 1.5x1.5 , 1.5x1 and 5x4 cm , enclosing 5 nodules up to 2.5x2 cm
-Left wide local excision specimen measured 10x9x2.5 cm with covering skin elipse measured 6x2 cm
- Tumor extent
  - Number: An ill defined firm greyish white mass
  - Size:4 x1.7x1.5 cm
  - Skin involvement: Free grossly
- Distance from margins:0.3 cm from lateral margin (least margin)
- Frozen section:

-Free SLNs(0/5)
-Free margins

Microscopic examination:
- Histological type:Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Not detected
- Ductal carcinoma in situ: focal
- Lymph node involvement:Free SLNs (0/5)
- Resection Margins: Free all resected margins

Verified by :
dr.esraa magdy

Branch No. (1) - First Floor Building No. 857, Nile Corniche - Misr El Qadima, Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

ارة الصـــــحة والسكـــان
ة المراكز الطبية المتخصصة
ستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Rashad Abdel Salam Aboul Sa'oud	Date : 04/06/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1576/2023	Pat. ID: 33356

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast shows UIQ spiculated irregular mass lesions, of high density.
- Complementary ultrasound revealed left breast irregular spiculated hypoechoic mass lesions, seen at 11 to 12 o'clock position 3.5 cm from the nipple, 0.7cm from the overlying skin, largest measuring 1.6 x 3.3 cm.
- The previously mentioned left breast 3 o'clock distortion shows no definite underlying spiculated mass lesions.
- Nonspecific bilateral axillary LN.
- No pathological enlarged left infra or supra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UIQ multifocal malignant looking mass lesions (BIRADS 6) for further CESM to exclude multicentricity.
- Benign findings right breast (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes

04/06/2023 7:48 PM

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصـــــحة والسكـــان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Nadia Rashad Abdel Salam Aboul Sa'oud	Date : 01/08/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 46 Year(s)
Medical ID: 1576/2023	Pat. ID: 33356

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left breast UQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

01/08/2024 5:20 PM

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Medical No. : 10431

Patient's Name: Nadia Rashad Abdel-Salam Abu Al-Saoud

Date: 2026-10-07

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post left CBS a, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UOQ architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UOQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes

Conclusion:-

- ***Right breast (BIRADS 1): Normal study.***
- ***Left breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequalae.***

Recommendation:-

- ***For annual follow up.***

PROF.MONA ZAKY

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]